ЛОР-справочник: разборы клинических рекомендаций

Сборка от 22.10.2026. Все пункты сверены с текстом КР Минздрава РФ.

1. Аллергический ринит
2. Наружные отиты
3. Носовое кровотечение
4. Острый синусит
5. Острый тонзиллит и фарингит
6. Отит средний острый
7. Паратонзиллярный абсцесс
8. Хронический тонзиллит

Аллергический ринит

Клинические рекомендации от 11.07.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

- **J30.1** Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений
- **J30.2** Другие сезонные аллергические риниты
- **J30.3** Другие аллергические риниты
- **J30.4** Аллергический ринит неуточнённый

Главное

- Диагноз ставят, когда хотя бы два из четырёх симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу) беспокоят ежедневно не меньше часа, прослеживается связь с аллергеном и аллергообследование положительное.
- Лечение подбирают по ступеням. На первой назначают один препарат: антигистаминный внутрь или в нос, кромоглициевую кислоту или монтелукаст. На второй предпочтителен назальный глюкокортикостероид. На третьей к нему добавляют один-два препарата из первой ступени, а четвёртая — омализумаб, который назначает только специалист.
- Назальные глюкокортикостероиды действуют сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты, особенно при выраженной заложенности.
- Сосудосуживающие капли назначают только при обострении с выраженной заложенностью и только коротким курсом, на 3–7 дней.
- Контроль оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения.

Клиника и классификация

Определение

Аллергический ринит — IgE-опосредованное воспаление слизистой оболочки носа, которое развивается под действием аллергенов. Хотя бы два симптома — заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа — проявляются ежедневно в течение часа и дольше.

Классификация

По причине выделяют сезонный, круглогодичный (бытовой) и профессиональный ринит. По течению — интермиттирующий, когда симптомы беспокоят меньше 4 дней в неделю или меньше 4 недель в году, и персистирующий, когда больше 4 дней в неделю и больше 4 недель в году.

При лёгком течении симптомы не мешают сну и дневным делам. При среднетяжёлом мешают работе, учёбе, спорту и нарушают сон. При тяжёлом без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать. Кроме того, различают обострение и ремиссию.

В диагнозе указывают аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельно выделяют локальный аллергический ринит. Симптомы типичные и чётко связаны с аллергеном, но кожные пробы и специфические IgE в крови отрицательны. Специфические IgE в носовом секрете в России не определяют, а назальные провокационные тесты положительны.

Жалобы

Основные жалобы — заложенность носа с дыханием ртом, сопением, храпом и изменением голоса; водянистые выделения; чихание, часто приступами по утрам; зуд, реже жжение в носу, иногда зуд нёба и глотки. Пациенты трут кончик носа ладонью («аллергический салют»), из-за чего появляется поперечная складка на носу. На поздних стадиях снижается обоняние.

Жалобы и анамнез собирают у каждого пациента с подозрением на аллергический ринит. При круглогодичной форме ведущий симптом — заложенность носа со слизистыми выделениями, при сезонной — приступы чихания, зуд и ринорея. Важно расспросить о связи симптомов с аллергеном и об аллергических болезнях у пациента и кровных родственников.

Из-за обильных выделений и нарушения проходимости слуховых труб бывают раздражение и отёк кожи над верхней губой и у крыльев носа, носовые кровотечения после сморкания, боль в горле и покашливание, боль и треск в ушах при глотании, снижение слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром — перекрёстная непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Проявления разные: от зуда во рту до анафилаксии.

Осмотр

Всем пациентам осматривают верхние дыхательные пути, проводят общий осмотр и аускультацию, чтобы не пропустить бронхиальную астму, конъюнктивит и атопический дерматит. Характерны затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот, тёмные круги под глазами, мацерация кожи над верхней губой, отёчность лица.

Диагностика

Диагноз ставят, когда есть характерные жалобы (два симптома из четырёх, ежедневно не меньше часа), анамнез указывает на связь с аллергеном или на другие аллергические болезни и аллергообследование положительно.

Пациента ведут вместе оториноларинголог и аллерголог-иммунолог. Оториноларинголог проводит риноскопию и эндоскопию, дифференциальную диагностику, выявляет осложнения и анатомические нарушения и определяет показания к операции. Аллерголог-иммунолог ставит кожные и провокационные тесты, оценивает их, исключает астму и решает вопрос об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

ЛОР-осмотр

Переднюю риноскопию проводят всем. Обычно видны отёк носовых раковин и много водянистого секрета. Слизистая ярко-красная при обострении сезонного ринита и цианотичная или серая при круглогодичном, бывает «мраморной» (симптом Воячека), могут быть полипы.

Эндоскопию полости носа, носоглотки и пазух проводят, если стандартное лечение не помогает или ринит осложнённый. Проба с сосудосуживающим средством показывает, обратима ли обструкция.

Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения. Подробнее — в разделе «Контроль лечения».

Аллергообследование

Если противопоказаний нет, ставят кожные пробы (prick-тесты или скарификационные), чтобы подтвердить аллергическую природу ринита, найти причинные аллергены и решить вопрос об АСИТ.

Пробы ставят в аллергологическом кабинете. На результат влияют возраст младше 5 и старше 60 лет, приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов, дермографизм (ложноположительный результат) и недавняя острая аллергическая реакция (ложноотрицательный).

Специфические IgE в крови определяют, если кожные пробы противопоказаны или невозможны, их результат сомнителен или расходится с анамнезом.

По методу ImmunoCAP результат считается положительным при значении больше 0,70 kU/l.

Общий IgE для диагностики не назначают: он неинформативен.

Анализы

Развёрнутый общий анализ крови назначают при выраженных симптомах в обострении или перед АСИТ. Смотрят эозинофилы; лейкоцитоз со сдвигом влево — повод искать инфекцию, прежде всего острый риносинусит.

При выраженных симптомах в обострении можно сделать цитологию смывов из носа. Для аллергического ринита характерна эозинофилия носового секрета — 10% и больше.

Общий IgE определяют только перед назначением омализумаба (с 12 лет, при тяжёлом течении), потому что по нему рассчитывают дозу.

Лучевая и функциональная диагностика

Рентгенографию пазух делают при симптомах риносинусита (гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, температура) или при лейкоцитозе со сдвигом влево.

КТ пазух нужна, если лечение не помогает, обструкция выраженная и длительная, держится аносмия или аллергообследование отрицательное. Прежде всего её делают при подозрении на полипозный риносинусит.

Спирометрию с бронхолитиком проводят при кашле, свистящем дыхании и одышке, а также перед АСИТ, чтобы выявить скрытый бронхоспазм.

Перед инъекционной АСИТ записывают ЭКГ.

Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит отличают от инфекционного ринита, аномалий внутриносовых структур, аденоидов у детей и полипозного риносинусита. Его отличают и от неаллергических ринитов: эозинофильного, лекарственного (НПВП, альфа- и бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, резерпин, долгий приём деконгестантов), гормонального (беременность, пубертат, менструальный цикл, контрацептивы, акромегалия, гипотиреоз), профессионального, атрофического ринита пожилых, пищевого и алкогольного, идиопатического. Кроме того, исключают первичную цилиарную дискинезию и муковисцидоз.

Лечение

Цель лечения — полный контроль симптомов. Если контакт с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями продолжается, можно добиться лишь уменьшения симптомов.

Ступени лечения

На любой ступени исключают контакт с аллергеном, при показаниях оперируют сопутствующую патологию и рассматривают АСИТ.

Ступень	Назначения
1-я ступень	Один препарат: антигистаминный внутрь без седативного эффекта, антигистаминный спрей в нос, кромоглициевая кислота в нос или монтелукаст.
2-я ступень	Один препарат, предпочтительно назальный глюкокортикостероид; можно антигистаминный внутрь или в нос либо монтелукаст.
3-я ступень	Назальный глюкокортикостероид вместе с одним или несколькими препаратами: антигистаминным внутрь или в нос, монтелукастом.

Ступень	Назначения
4-я ступень	Омализумаб при тяжёлом течении, с 12 лет. Назначает только специалист.
Для быстрой помощи	Сосудосуживающие капли коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Прежде чем переходить на ступень выше, перепроверьте диагноз, приверженность лечению, сопутствующие болезни и анатомические аномалии.

Антигистаминные препараты внутрь

Антигистаминные препараты без седативного эффекта назначают всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность. Цетиризин в больших дозах вызывает сонливость чаще остальных.

Седативные антигистаминные первого поколения не назначают: они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при весе до 30 кг — 5 мг, больше 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Есть форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

Назальные глюкокортикостероиды

Их назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно при выраженной заложенности. Они сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты и помогают также при глазных симптомах. Возможны сухость, носовые кровотечения, редко перфорация перегородки, поэтому пациента нужно научить правильно вводить спрей.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддержки — 200 мкг в сутки. Не дольше 3 месяцев.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, это максимальная доза; для поддержки — 1 доза 2 раза в сутки.

Антигистаминные спреи и комбинации

Антигистаминные спреи быстро уменьшают симптомы, в течение 30 минут. Их назначают отдельно или вместе с другими препаратами; возможна сухость слизистой.

Если нужны и антигистаминный, и гормональный спрей, удобнее назначить один комбинированный.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не дольше 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. Если за 3 дня эффекта нет, препарат отменяют.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

Монтелукаст и кромоглициевая кислота

Монтелукаст можно назначать при любой тяжести, отдельно или вместе с другими препаратами, но он слабее назальных глюкокортикостероидов.

Если у пациента ещё и бронхиальная астма, монтелукаст помогает контролировать обе болезни. Курс — от 1 до 3 месяцев и дольше; по инструкции ограничений по длительности нет.

Если нужны и антигистаминный препарат внутрь, и монтелукаст, можно назначить комбинированную таблетку левоцетиризина с монтелукастом.

Кромоглициевую кислоту в нос назначают при лёгком течении. Она безопасна, но слабее антигистаминных препаратов, монтелукаста и назальных глюкокортикостероидов.

Препарат	Доза
Монтелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монтелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. Когда наступит эффект, можно применять только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью их назначают коротким курсом, на 3–7 дней.

Длительные курсы не назначают: после 10 дней развиваются привыкание, отёк слизистой и медикаментозный ринит.

Если нужны и антигистаминный, и сосудосуживающий препарат в нос, можно назначить комбинацию диметиндена с фенилэфрином, не дольше 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не дольше 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или если третья ступень не помогает, можно назначить короткий курс глюкокортикоидов внутрь.

Это четвёртая линия или лечение тяжёлого обострения. Вводить растворы и депо-формы глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо: это грозит тяжёлыми осложнениями вплоть до слепоты. Дозу преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирают индивидуально; преднизолон в таблетках противопоказан детям до 3 лет.

Депо-формы глюкокортикоидов не назначают: побочные эффекты развиваются быстро, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Омализумаб рассматривают с 12 лет при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении, если третья ступень не помогает.

Его вводят подкожно раз в 2 или 4 недели, доза от 75 до 600 мг — по таблице дозирования. При сезонном рините начинают хотя бы за неделю до начала пыления и продолжают до его окончания.

Без лекарств

Всем пациентам рекомендуют по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение облегчает течение и снижает потребность в лекарствах.

Всем рекомендованы изотонические солевые растворы для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением назального глюкокортикостероида нос промывают: так препарат лучше контактирует со слизистой, а сухость и кровотечения возникают реже.

Аллерген-специфическая иммунотерапия

АСИТ рассматривают у всех пациентов в ремиссии, в том числе медикаментозной. Она уменьшает симптомы и потребность в лекарствах, предупреждает развитие астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяет аллерголог-иммунолог, он же назначает АСИТ.

Хирургическое лечение

Операцию проводят только при сопутствующей патологии; показания определяет оториноларинголог по данным эндоскопии и рентгенологического обследования. Плановые операции в сезон пыления причинных аллергенов не проводят.

Нетрадиционные методы

Гомеопатию, фитотерапию, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапию не рекомендуют: доказательств их пользы нет.

Иглоукалывание можно рассмотреть в составе комплексного лечения.

Дети, беременность, кормление грудью

С какого возраста можно детям

Мометазон и флутиказона фуроат разрешены с 2 лет, флутиказона пропионат — с 4 лет, беклометазон и будесонид — с 6 лет.

Цетиризин и дезлоратадин разрешены с 6 месяцев, лоратадин — с 2 лет. Антигистаминные первого поколения (хлоропирамин, диметинден) разрешены с 1 месяца, но, когда ребёнок дорастёт до нужного возраста, предпочтение отдают препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст в дозе 4 мг разрешён с 2 лет, в дозе 5 мг — с 6 лет.

АСИТ по инструкциям к препаратам проводят с 5 лет.

Назальные глюкокортикостероиды назначают детям в минимальной эффективной дозе, а при длительном применении следят за ростом.

Лучше ограничить препараты с высокой биодоступностью — будесонид (30–40%) и беклометазон (40–50%). У дексаметазона биодоступность больше 80%; это важно помнить, потому что он входит во многие комбинированные капли.

Беременность и кормление грудью

У беременных нужно помнить о рините беременных: заложенность носа без признаков инфекции и аллергии, которая полностью проходит в течение 2 недель после родов. Выявленная сенсибилизация говорит в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и кормления не ставят; вместо них определяют специфические IgE в крови.

Предпочтение отдают ограничению контакта с аллергеном и промыванию носа. Лекарства назначают, если этого недостаточно, взвешивая риск для матери и ребёнка.

Доказательств риска для человека нет у лоратадина, цетиризина и будесонида (категория B по классификации FDA).

В первом триместре лекарства по возможности не назначают, если в них нет жизненной необходимости.

При кормлении грудью лучше ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью: все системные препараты проникают в молоко.

Контроль лечения

Визуальная аналоговая шкала — линия длиной 10 см, на которой пациент отмечает, насколько его беспокоят симптомы. Если отметка от 0 до 50 мм, ринит контролируется, если 50 мм и больше — не контролируется.

У подростков и взрослых при отметке 5 см и больше начинают с антигистаминных препаратов на 2–4 недели. Если ринит стал контролируемым, лечение продолжают по потребности и рассматривают АСИТ. Если нет, добавляют назальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё на 2–4 недели. Если и тогда контроля нет, пересматривают диагноз, ищут сопутствующую патологию, рассматривают АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит считается контролируемым, если за последние 4 недели не было симптомов, не нарушались сон и дневная активность, а тест «дыхание с закрытым ртом» нормальный. Любое отклонение, в том числе более частая потребность в препаратах быстрой помощи, означает потерю контроля, и тогда можно переходить на ступень выше.

Для теста пациента просят закрыть рот и 30 секунд дышать только носом.

Для дневника симптомов (шкала TNSS) пациент каждый день оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов, сумма — от 0 до 12. Врач считает среднее за 7 дней. Дневник ведут в обострение и для оценки эффекта АСИТ.

Отдельно оценивают лекарства: только антигистаминные — 1 балл, назальные глюкокортикостероиды — 2, системные глюкокортикоиды — 3.

Наблюдение, профилактика, госпитализация

Каждому пациенту или его представителям объясняют суть болезни, составляют индивидуальный план лечения и учат управлять болезнью самостоятельно.

Пациенты находятся на диспансерном наблюдении у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые приходят не реже раза в год, дети — не реже двух раз в год. Наблюдение пожизненное или до стойкой ремиссии длительностью 3 года и больше.

АСИТ используют и для вторичной профилактики: она помогает предупредить астму, утяжеление ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации советуют ограничить перекрёстно-реагирующие продукты и растительные лекарства.

Лечат обычно амбулаторно. Госпитализируют при крайне тяжёлом или осложнённом течении, детей — при тяжёлом обострении с выраженной заложенностью, а также планово для ускоренного курса АСИТ. Выписывают, когда симптомы под контролем или курс АСИТ завершён.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная — как «22.4 мкг». Сверьте с инструкцией в ГРЛС.
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», а в оригинальном названии — «untreated patients», то есть не получавших лечения.
- В тексте доз мометазона и флутиказона фуроата повторяются обрывки фраз; на смысл доз это не влияет.

Наружные отиты

Клинические рекомендации от 13.11.2024 · взрослые

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

- **H60.0** Абсцесс наружного уха — фурункул, карбункул, нарыв ушной раковины или слухового прохода
- **H60.1** Целлюлит наружного уха
- **H60.2** Злокачественный наружный отит
- **H60.3** Другие инфекционные наружные отиты — диффузный, геморрагический, «ухо пловца»
- **H60.4** Холестеатома наружного уха
- **H60.5** Острый наружный отит неинфекционный — актиничный, химический, контактный, экзематозный, реактивный
- **H60.8** Другие наружные отиты — хронический наружный отит
- **H60.9** Наружный отит неуточнённый
- **H61.0** Перихондрит наружного уха
- **H61.8** Другие уточнённые болезни наружного уха
- **H61.9** Болезнь наружного уха неуточнённая
- **H62.0** Наружный отит при бактериальных болезнях — при рожистом воспалении
- **H62.1** Наружный отит при вирусных болезнях — при герпесе, опоясывающем лишае
- **H62.3** Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях
- **H62.4** Наружный отит при других болезнях
- **H62.8** Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

Главное

- Наружный отит — воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- Неосложнённый наружный отит лечат местно: ушными каплями, а при бактериальном отите в первую очередь фторхинолонами. Всем нужны туалет слухового прохода и обезболивание.
- Системные антибиотики при неосложнённом отите не назначают. Они нужны при постлучевом отите, сахарном диабете, иммуносупрессии и хондроперихондрите.
- Эффект оценивают через 48–72 часа. Если его нет, уточняют диагноз: это может быть атопический или контактный дерматит, псориаз или экзема.
- При злокачественном наружном отите сильная боль, грануляции, в посеве синегнойная палочка, лечение не помогает больше недели; чаще болеют пожилые с сахарным диабетом. Нужны глюкоза крови, КТ, госпитализация и антибиотики не меньше 6 недель.

Клиника и классификация

Определение

Наружный отит — воспалительные изменения ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

Отит бывает острым и хроническим, если длится дольше 6–12 недель. Диффузный наружный отит включает экзему, дерматит, рожу, герпес, перихондрит, хондроперихондрит и злокачественный наружный отит. Ограниченный — это фурункул и абсцесс.

Воспаление начинается с повреждения кожи: травмы, долгого пребывания во влажной среде, сахарного диабета, дерматита или экземы. Предрасполагают узкий слуховой проход, экзостозы, слуховой аппарат, попадание воды, нарушение образования серы и облучение.

Жалобы

Пациенты жалуются на дискомфорт и боль в ухе, часто сильнее при надавливании и жевании; боль может отдавать в глаз, зубы, глотку. Слух снижается, если слуховой проход полностью закрыт. Иногда беспокоят зуд и выделения. Температура обычно субфебрильная.

Осмотр

При осмотре видны гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи слухового прохода, иногда ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки, а также патологическое отделяемое. При ограниченной форме находят абсцессы и инфильтраты, бывает регионарный лимфаденит.

Особенности форм

Фурункул слухового прохода в стадии инфильтрации вызывает дискомфорт, который усиливается при манипуляциях в ухе, а после формирования абсцесса на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения и иногда снижение слуха.

При экзематозном отите видны желтовато-розовые очаги с чешуйками, беспокоит зуд, иногда сильный и появляющийся раньше высыпаний. Затем образуются микровезикулы, эрозии и мокнутие, причём элементы разных стадий видны одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний появляются жжение, зуд и покалывание, затем эритема, пузырьки и корочки. Обычно всё проходит за 10–14 дней, при вторичной инфекции — за 3–4 недели.

Диагностика

Диагноз ставят по характерным жалобам и клинической картине; при необходимости его подтверждают лабораторно и другими методами.

Отделяемое отправляют на посев на бактерии, на микроскопию и посев на грибы, делают цитологию; при подозрении на новообразование — биопсию.

Мазок берут до начала противомикробного лечения, под контролем отоскопии, тампоном на глубине до 0,3 см из просвета или со стенок слухового прохода, не касаясь его наружных отделов.

Если после стихания воспаления пациент жалуется на снижение слуха, проводят аудиометрию, чтобы исключить острую нейросенсорную тугоухость. При неосложнённом наружном отите возможна кондуктивная тугоухость.

КТ и МРТ нужны при осложнённой форме, когда есть костные секвестры или абсцессы, чтобы оценить распространённость процесса. При неосложнённом отите лучевая диагностика не нужна.

Если наружное ухо поражено на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания, пациента направляют к профильному специалисту и дообследуют.

Злокачественный наружный отит

При злокачественной форме определяют глюкозу крови, чтобы выявить сахарный диабет: в 90–100% случаев злокачественный отит сочетается с ним.

Основные признаки злокачественного наружного отита: боль в ухе и головная боль на стороне поражения, отёк стенок и выделения из слухового прохода, грануляции в нём, микроабсцессы в области уха и основания черепа, очаг воспаления на сцинтиграфии, отсутствие эффекта от лечения больше недели и синегнойная палочка в посеве.

Дополнительно учитывают сахарный диабет, поражение черепных нервов, истощение и пожилой возраст. Если сцинтиграфию сделать нельзя, назначают местное лечение на 1–3 недели: отсутствие улучшения говорит в пользу злокачественного отита.

Лечение

Всем пациентам устраняют предрасполагающие факторы, хорошо обезболивают и регулярно проводят туалет наружного слухового прохода.

Местное лечение

Неосложнённый наружный отит лечат местно, препаратами, которые действуют на золотистый стафилококк и синегнойную палочку. Эффект оценивают через 48–72 часа. Если симптомы держатся, уточняют диагноз: это может быть атопический или контактный дерматит, псориаз или экзема.

При бактериальном наружном отите ушные капли с фторхинолонами — препараты первого выбора.

Ушные капли назначают всем пациентам с бактериальным наружным отитом; варианты — в таблице ниже.

При любой форме применяют антисептики (бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид; йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом) и противомикробные средства: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые. При местном лечении 65–95% пациентов выздоравливают на 7–10-е сутки.

При экзематозной форме назначают кортикостероиды вместе с противомикробными средствами.

Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР — «Комбинил»)	антибактериальный — ципрофлоксацин; противовоспалительный — дексаметазон	с 18 лет
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B	антибактериальный — неомицин + полимиксин B; анестетик — лидокаин	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	антибактериальный — хлорамфеникол; противогрибковый — клотримазол; противовоспалительный — беклометазон; анестетик — лидокаин	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B	антибактериальный — неомицин + полимиксин B; противовоспалительный — дексаметазон	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	антибактериальный — фрамицетин + грамицидин; противовоспалительный — дексаметазон	без ограничений

> В этой КР капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, а в КР «Отит средний острый» — детям старше 1 года. Проверьте возраст по инструкции в ГРЛС.

Системные антибиотики

При неосложнённом наружном отите системные антибиотики не назначают: если добавить их к местному лечению, результат не улучшается.

Системные антибиотики нужны при постлучевом наружном отите, сахарном диабете и иммуносупрессии.

Злокачественный наружный отит лечат системными антибиотиками не меньше 6 недель; препараты должны действовать на синегнойную палочку и стафилококк.

При хондроперихондрите ушной раковины назначают системные антибиотики и противовоспалительные средства, чтобы снять боль и отёк.

Хирургия и другое

При ограниченном отите вскрывают и дренируют абсцессы слухового прохода. При злокачественном удаляют грануляции, костные и хрящевые секвестры и холестеатому в пределах зоны поражения.

Для повышения эффективности лечения применяют физиотерапию.

Посевы повторяют до тех пор, пока не подтвердится, что возбудитель исчез.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе контролируют уровень глюкозы крови.

Профилактика и госпитализация

Для профилактики советуют реже пользоваться ватными палочками и не чистить слуховой проход слишком часто, а также соблюдать гигиену берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечат обычно амбулаторно, а при некротическом (злокачественном) наружном отите госпитализируют. Выписывают, когда воспаление в слуховом проходе стихло и гнойно-септических осложнений нет.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

Неточности в самом тексте КР

- Норфлоксацин в каплях: здесь — с 15 лет, в КР «Отит средний острый» — детям старше 1 года.
- В таблице 1 у фрамицетина с дексаметазоном антибактериальный компонент назван «Грамидин»; по названию препарата — грамицидин.
- Одна строка таблицы 1 дана торговым названием «Комбинил» (ципрофлоксацин + дексаметазон).
- Сокращение «зО» в разделе 2.5 — по смыслу злокачественный наружный отит.

Носовое кровотечение

Клинические рекомендации от 08.12.2025 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/977_1. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

R04.0 Носовое кровотечение

Главное

- При кровотечении из передних отделов носа сначала плотно прижимают крылья носа к перегородке на 5 минут и дольше.
- Если кровотечение не угрожает жизни, сначала его останавливают местно — прижатием, сосудосуживающим средством, коагуляцией или тампонадой, — и только потом корректируют свёртываемость или отменяют антикоагулянты.
- Если кровотечение продолжается, а источник не виден, ставят переднюю тампонаду.
- Всем пациентам измеряют артериальное давление: это помогает выявить гипертензию и оценить кровопотерю.
- Госпитализируют, если первичные меры не помогли, кровопотеря большая или кровотечение интенсивное, есть признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология или высокий риск рецидива, а также всегда при переливании крови, задней тампонаде, перевязке сосудов и эмболизации.

Клиника и классификация

Определение

Носовое кровотечение — кровотечение из повреждённых сосудов полости носа, околоносовых пазух или носоглотки, а также из сосудов полости черепа при повреждении верхней стенки полости носа.

Причины

Кровотечения бывают посттравматическими, в том числе после операций, и спонтанными. Спонтанное кровотечение — симптом местной или общей болезни.

Сосуды слизистой носа страдают при её атрофии, специфическом воспалении (туберкулёз, сифилис), опухолях носа и пазух, сосудистых мальформациях и гранулематозе с полиангиитом.

У детей кровотечение чаще всего вызвано повреждением слизистой (инородное тело, травма, в том числе ятрогенная), острыми инфекциями верхних дыхательных путей и опухолями.

У детей до двух лет носовое кровотечение бывает очень редко, примерно у одного из 10 000. Если оно случилось в этом возрасте, нужно исключить болезни крови и врождённую патологию, например гемангиому полости носа и носоглотки.

Классификация

По механизму кровотечение бывает вызвано изменениями сосудов носа, нарушением свёртывания крови или сочетанием причин. По источнику — из передних или задних отделов полости носа, из околоносовых пазух, носоглотки или внутричерепных сосудов.

Клиническая картина

При переднем кровотечении кровь в основном течёт наружу, при заднем — стекает в носоглотку.

Пациенты жалуются на кровянистые выделения из носа, часто на стекание крови по задней стенке глотки и недомогание. Если кровь заглатывалась, бывают дискомфорт в животе, тошнота и чёрный стул.

Общие симптомы и объём кровопотери

Шок	Признаки	Кровопотеря
Не выражен	Признаков нет	до 10% объёма крови (до 500 мл)
Лёгкий	Пульс до 100, систолическое давление выше 100 мм рт. ст., холодные конечности, нормальный диурез	15–20% (750–1250 мл)
Средний	Пульс до 120, систолическое давление 90–100 мм рт. ст., сниженное пульсовое давление, беспокойство, потливость, бледность, диурез меньше 50 мл в час	25–35% (1250–1750 мл)
Тяжёлый	Пульс больше 120, систолическое давление ниже 60 мм рт. ст. или не определяется, ступор, резкая бледность, холодные конечности, сухие язык и кожа, анурия	больше 35% (больше 1750 мл)

Анамнез

Уточняют, когда началось кровотечение, сколько длится и как часто повторяется, с какой стороны были прошлые кровотечения, были ли из-за них госпитализации и переливания крови. Расспрашивают о приёме антиагрегантов, антикоагулянтов и других препаратов, о гипертензии, коагулопатиях, анемии, кровотечениях у родственников, травмах и операциях на носу и пазухах.

Носовое кровотечение может быть первым признаком коагулопатии, наследственной телеангиэктазии, опухоли носа или носоглотки, болезни печени или почек, особенно если оно повторяется. Синяки и петехии без причины и кровотечения из внутренних органов в анамнезе говорят в пользу системного нарушения свёртывания.

Кровотечение на фоне антикоагулянтов (варфарин, гепарин, дабигатран, апиксабан и другие) или антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) может потребовать отмены или снижения дозы. У таких пациентов кровотечения чаще повторяются и чаще бывают больше 250 мл, требуя переливания крови. Риск повышают также многие спреи для носа, в том числе сосудосуживающие и гормональные, и некоторые наркотические вещества.

Диагностика

Диагноз ставят, когда кровянистые выделения из носа подтверждены при риноскопии и фарингоскопии.

Осмотр

Каждого пациента осматривает оториноларинголог: оценивает состояние, ищет источник кровотечения и выбирает тактику.

Если госпитализация нужна, выбирают стационар с дежурным оториноларингологом. Если во время кровотечения ЛОР-врач пациента не осмотрел, в том числе потому, что кровотечение остановилось само, пациента направляют к нему планово.

Оценивают пульс, сознание, кожу и слизистые, чтобы не пропустить гиповолемию. Обморок, тахикардия, тахипноэ и бледность говорят о гемодинамических нарушениях из-за кровопотери. Кровоизлияния на коже и слизистых без травмы могут указывать на системное нарушение свёртывания.

При повторных кровотечениях из обеих половин носа или если они бывают у родственников, ищут телеангиэктазии на слизистой носа и рта, чтобы не пропустить наследственную геморрагическую телеангиэктазию (болезнь Рандю — Ослера — Вебера).

Всем пациентам измеряют артериальное давление, чтобы выявить гипертензию и оценить гиповолемию: гипотония может говорить о значительной кровопотере.

Если источник не виден при передней риноскопии, проводят эндоскопию полости носа и носоглотки.

Повторяющееся кровотечение с одной стороны может быть первым признаком опухоли, которую не видно при передней риноскопии, а у детей — инородного тела.

Анализы

Общий анализ крови назначают, чтобы оценить постгеморрагическую анемию и тромбоциты; для оценки кровопотери определяют гемоглобин и гематокрит.

Степень кровопотери у взрослого

Степень	Объём кровопотери	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
I	до 500 мл	больше 120	больше 40
II	500–1000 мл	100–120	30–40
III	1000–1500 мл	80–100	20–30
IV	больше 1500 мл	меньше 80	меньше 20

При повторяющихся кровотечениях и при кровотечении, требующем госпитализации, исследуют гемостаз: МНО, фибриноген, АЧТВ и протромбиновое время. МНО особенно важно у пациентов на варфарине: значение выше 4,5 прогностически неблагоприятно.

При приёме прямых пероральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан и др.) эти показатели могут не отражать степень гипокоагуляции.

Консультации

Если есть гипертензия, анемия, коагулопатия или другие сопутствующие болезни, влияющие на кровотечение, пациента консультирует терапевт или педиатр.

При повторяющихся кровотечениях с признаками тромбоцитопатии или коагулопатии в анализах пациента консультирует гематолог.

Лечение

Цель — остановить кровотечение, устранить факторы риска и скорректировать последствия кровопотери, включая гиповолемию и анемию.

Если кровотечение не угрожает жизни, сначала его останавливают местно: прижатием крыльев носа, сосудосуживающим средством, коагуляцией или тампонадой. Только после этого корректируют свёртываемость или отменяют антикоагулянты и антиагреганты, потому что системная коррекция опасна, прежде всего тромбоэмболиями.

Остановка кровотечения

При кровотечении из передних отделов носа сначала плотно прижимают крылья носа к перегородке на 5 минут и дольше, обычно на 5–15 минут. Перед этим пациент сморкается, чтобы удалить сгустки; сидит или стоит, слегка наклонив голову вперёд. Это может сделать и сам пациент. Если кровь продолжает стекать, источник, скорее всего, находится глубже, и нужны другие методы.

Если кровотечение продолжается, а источник найден, взрослым на него накладывают турунду с сосудосуживающим средством, а взрослым и детям можно приложить гемостатик.

Однократно применяют #ксилометазолин или #эпинефрин на турунде; #оксиметазолин в спрее — по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 3 раза в день 3–5 дней (знак # означает применение вне инструкции). Сосудосуживающие препараты осторожно применяют при гипертензии, ИБС и ишемии мозга.

На турунде можно однократно приложить к источнику #транексамовую кислоту (взрослым: 5 мл на кусочек ваты или марли на 10–30 минут) или этамзилат (взрослым и детям).

Если кровотечение продолжается, а источник найти не удаётся, ставят переднюю тампонаду.

Рассасывающиеся материалы, например коллагеновая гемостатическая губка, не нужно удалять, и это их преимущество: при удалении тампона кровотечение может возобновиться. Поэтому при высоком риске повторного кровотечения, например при наследственной телеангиэктазии или болезнях крови, по возможности используют их. У детей источник обычно спереди, поэтому, если ребёнок позволяет, лучше обойтись без тампона; если он не готов к манипуляциям, предпочтительна передняя тампонада.

Если кровотечение из задних отделов не останавливается передней тампонадой, ставят переднюю и заднюю тампонаду с тампоном в области хоан и носоглотки.

Пациента с задним тампоном наблюдают и лечат в стационаре. Нитка или фиксатор не должны сильно давить на крыло носа, иначе образуется пролежень. Некоторые авторы назначают при задней тампонаде системные антибиотики.

Если кровотечение продолжается и источник найден, кровоточащий сосуд коагулируют.

Коагулировать можно химически (нитратом серебра), электрокоагулятором, лазером или радиоволной. Если перед этим приложить сосудосуживающее средство, коагуляция эффективнее.

Если коагуляция и тампонада не помогают, рассматривают эмболизацию сосудов или перевязку артерии.

В редких случаях перевязывают наружную сонную артерию на стороне кровотечения. Эмболизация эффективна до 87% случаев, но осложняется чаще, чем перевязка; её можно делать под седацией и при стоящих тампонах.

При повторяющихся кровотечениях из зоны Киссельбаха отслаивают слизистую перегородки носа.

Операцию не делают при субатрофии слизистой и выраженном искривлении перегородки.

Лекарства

При повышенном давлении назначают антигипертензивные препараты: так уменьшаются кровопотеря и риск рецидива.

Если первичные меры недостаточны, назначают гемостатики: транексамовую кислоту (внутривенно с 1 года, в таблетках с 3 лет), аминокапроновую кислоту, аминометилбензойную кислоту, этамзилат — в дозах по инструкции. При продолжающемся кровотечении лучше вводить внутривенно, таблетки подходят для профилактики рецидивов.

Этамзилат системно оправдан только при диапедезном кровотечении из мелких сосудов слизистой.

При травматическом кровотечении или риске тяжёлого кровотечения пациентам старше года как можно раньше, лучше в первые 3 часа после травмы, вводят транексамовую кислоту внутривенно.

Пациентов с коагулопатиями и переливание крови по возможности ведут вместе с гематологом, терапевтом или педиатром.

Детям с геморрагическим синдромом при дефиците витамина K вводят менадиона натрия бисульфит: новорождённым — до 4 мг в сутки, от месяца до года — 2–5 мг в сутки. Можно вводить и профилактически, не дожидаясь подтверждения дефицита.

После кровотечения или его остановки назначают увлажняющие и заживляющие средства для слизистой носа.

Они уменьшают сухость и корки, чтобы пациент не чистил нос сам; показаны и при субатрофическом рините.

Профилактика и госпитализация

Пациентам объясняют факторы риска повторного кровотечения, как останавливать его самому и когда обращаться к врачу.

Объясняют, что нельзя ковырять в носу, особенно детям, родителям и пожилым; пожилым — что риск связан с лекарствами и подъёмом давления. Слизистую сушат кислородные канюли и аппараты для дыхания под давлением. Пациентам на варфарине обязателен контроль МНО. Если кровотечения повторяются на фоне спреев для носа, дозу уменьшают и учат правильно ими пользоваться.

Если кровотечение связано с повышением давления, пациента консультирует терапевт, педиатр или кардиолог, чтобы подобрать антигипертензивную терапию.

Госпитализация

Нужна ли госпитализация после передней тампонады, решают по длительности кровотечения, объёму кровопотери, признакам гиповолемии, сопутствующим болезням, типу тампона и доступности амбулаторной помощи. При активном кровотечении или нестабильной гемодинамике пациента обследуют и лечат в приёмном или ЛОР-отделении.

При кровотечении на фоне гипертонической болезни ЛОР-врач останавливает кровотечение в приёмном отделении, затем пациента госпитализируют в терапевтический стационар, чтобы нормализовать давление.

При небольшом или уже остановившемся кровотечении пациента можно обследовать амбулаторно.

Госпитализируют, если первичные меры не помогли, кровопотеря значительная или кровотечение интенсивное, есть признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология или высокий риск рецидива. Всегда госпитализируют при переливании крови, задней тампонаде, перевязке сосудов и эмболизации, а также после передней тампонады нерассасывающимся материалом, если удалить тампоны амбулаторно нельзя.

Значительной считается кровопотеря больше 10% объёма крови (около 500 мл у взрослого), интенсивным — кровотечение больше 1 мл/кг в минуту. Риск тяжёлого кровотечения повышают госпитализации из-за кровотечений в анамнезе, особенно с переливанием крови, и больше трёх эпизодов за последние 3 месяца.

Выписывают, когда кровотечение стойко остановлено, признаков гиповолемии нет, гемодинамика нормальная, а сопутствующие болезни компенсированы.

Исход во многом определяют скорость и объём кровопотери: массивная кровопотеря больше 40% объёма крови может быть несовместима с жизнью.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Носовое кровотечение»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 08.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	977_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- У рекомендации о гемостатической терапии уровень доказательств записан как «уровень доказательств – 4» вместо принятого «уровень достоверности доказательств».

- В оглавлении PDF вместо номеров страниц нескольких разделов стоит «Ошибка! Закладка не определена».

Острый синусит

Клинические рекомендации от 28.10.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

нажмите код — скопируется

- **J01.0** Острый верхнечелюстной синусит
- **J01.1** Острый фронтальный синусит
- **J01.2** Острый этмоидальный синусит
- **J01.3** Острый сфеноидальный синусит
- **J01.4** Острый пансинусит
- **J01.8** Другой острый синусит
- **J01.9** Острый неуточнённый синусит

Главное

- Острый синусит — острое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, которое длится меньше 12 недель. Должны быть хотя бы два симптома: заложенность носа, выделения из носа или носоглотки, давление или боль в области лица, снижение или потеря обоняния.
- В 90–98% случаев синусит вызывают вирусы, бактерии — лишь в 2–10%.
- Системные антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком — только если синусит рецидивирующий и симптомы держатся 5–7 дней и дольше, при тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефиците.
- При впервые возникшем синусите начинают с незащищённого аминопенициллина — амоксициллина. Если за 3 дня заметного эффекта нет, препарат меняют.
- Сосудосуживающие капли назначают не дольше 5–7 дней, нос промывают солевыми растворами, пациентам старше 12 лет можно интраназальные глюкокортикостероиды.
- Госпитализируют при тяжёлом течении, орбитальных или внутричерепных осложнениях, если за 3–5 дней приёма системных антибиотиков нет улучшения и при ухудшении в любой момент.

Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

Определение

Острый синусит — острое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, которое длится меньше 12 недель. Должны быть хотя бы два симптома: затруднённое носовое дыхание, выделения из носа или носоглотки, давление или боль в области лица, снижение или потеря обоняния. Часть симптомов может заменить находка при риноскопии, эндоскопии или на КТ.

У детей внезапно появляются хотя бы два симптома: заложенность носа, бесцветные или светлые выделения, кашель днём или ночью. Симптомы должны полностью пройти за 12 недель.

Рецидивирующим синусит называют, если за последний год было 4 эпизода и больше, а между ними — не меньше 8 недель без симптомов и без лечения.

Об остром поствирусном синусите говорят, если симптомы держатся дольше 10 дней после ОРВИ, а признаков бактериального синусита нет. Обычно он протекает легче и проходит без антибиотиков.

Критерии диагноза

У взрослых синусит начинается остро, симптомов два или больше, и один из них — заложенность носа или выделения, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки. Могут быть боль или давление в проекции пазух, снижение или потеря обоняния. Длится не дольше 12 недель.

У детей синусит начинается остро, есть хотя бы два симптома: заложенность носа, выделения из носа, в том числе по задней стенке глотки, или кашель. Длится не дольше 12 недель.

Предварительный диагноз оториноларинголог подтверждает риноскопией или эндоскопией (гнойное отделяемое или отёк в области остиомеатального комплекса) либо КТ.

Боли может и не быть. При верхнечелюстном синусите она ощущается в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья и может отдавать в верхние зубы. При сфеноидите болит в центре головы и в затылке, как будто надета каска.

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или сильно затруднённым носовым дыханием.

Тяжесть

Форма	Признаки
Лёгкая	Нет лихорадки. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Нет головной боли в проекции ОНП. Нет осложнений
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Тяжесть в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Нет внутричерепных и орбитальных осложнений
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

Классификация

По причине синусит бывает вирусным, бактериальным, травматическим, грибковым (как острый процесс — очень редко) и смешанным. Чисто бактериальный синусит встречается редко; обычно это сочетание вирусов или вирусов с бактериями.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Если поражены все пазухи одной половины носа, это гемисинусит, если обеих — пансинусит.

Дифференциальная диагностика

У взрослых синусит отличают от обострения хронического риносинусита, аллергического и хронических ринитов, у детей — ещё от аденоидита и инородного тела в носу.

Дошкольникам без осложнений и без признаков бактериального синусита основным диагнозом лучше ставить аденоидит или острый назофарингит.

Диагностика

раздел 2 текста КР
Всем пациентам проводят общий осмотр и стандартный ЛОР-осмотр.

Эндоскопию полости носа и носоглотки проводят, чтобы оценить их состояние и провести дифференциальную диагностику.

Чаще всего она не даёт больше, чем передняя и средняя риноскопия, но помогает, например, отличить сфеноидит от аденоидита.

Спиральную КТ околоносовых пазух делают при подозрении на внутричерепные или орбитальные осложнения, при затяжном тяжёлом течении и в сложных диагностических случаях.

Рентгенографию пазух делают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, а также в сложных случаях, если КТ сделать нельзя.

Рентгенография и КТ пазух совпадают только в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи — в 77%.

УЗИ пазух делают при подозрении на верхнечелюстной или лобный синусит, если рентгенография и КТ невозможны.

Развёрнутый общий анализ крови назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении.

Лейкоцитоз с нейтрофилёзом не доказывает бактериальный синусит, но если при повторном анализе он нарастает, это помогает решить вопрос об антибиотиках.

Гнойное отделяемое отправляют на посев с определением чувствительности в стационаре при среднетяжёлом и тяжёлом течении, при затяжном течении и если эмпирическая антибиотикотерапия не помогла.

Материал берут при пункции пазухи иглой Куликовского. Посев из носового хода делать бессмысленно: в него попадает посторонняя флора.

Другие исследования не нужны.

Лечение

раздел 3 текста КР

Когда нужен антибиотик

Взрослым антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком — только если синусит рецидивирующий и симптомы держатся 5–7 дней и дольше, а также при тяжёлой сопутствующей патологии (например, сахарном диабете) и иммунодефиците.

О бактериальном синусите говорят три признака и больше: гнойные выделения или выделения только из одной половины носа 3 дня и дольше; головная боль или давление в проекции верхнечелюстных или лобных пазух; температура 38,0 °C и выше; «вторая волна» болезни; лейкоцитоз выше 15×10^9/л. О нём же говорят выраженные с самого начала симптомы, которые держатся 3–4 дня и угрожают орбитальными или внутричерепными осложнениями.

Детям антибиотики назначают при признаках бактериального синусита, среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком — если есть хотя бы одно из условий: орбитальные или внутричерепные осложнения; три и больше признака бактериального синусита; иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа; 4 эпизода синусита и больше за последний год.

Взрослым при наличии показаний назначают системные антибиотики.

Детям при наличии показаний назначают системные антибиотики.

При впервые возникшем синусите начинают с незащищённых аминопенициллинов.

Если высок риск устойчивого пневмококка, дозу амоксициллина повышают. При сопутствующих болезнях, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и если амоксициллин уже не помог, начинают с защищённых аминопенициллинов.

Если за 3 дня заметного эффекта нет, препарат меняют, не дожидаясь конца курса. У детей эффект оценивают через 48–72 часа.

Дозы стартовой терапии

Взрослые | Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР — со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают антибиотики в предыдущие 3 месяца, дети-дошкольники в семье, которые ходят в детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит, иммуносупрессия, возраст старше 65 лет и неудачное лечение амоксициллином.

Неосложнённый синусит лечат 7 дней, осложнённый — 10–14 дней.

Макролиды — только запасной вариант при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны можно только взрослым и только если других вариантов нет; детям и подросткам они противопоказаны.

Тяжёлое течение, парентерально

Взрослым при тяжёлом синусите вводят цефотаксим или цефтриаксон, внутривенно можно также амоксициллин с клавулановой кислотой. При риске анаэробов назначают клиндамицин вместе с цефалоспорином III поколения. Если стартовая парентеральная терапия не помогла, рассматривают цефоперазон с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, а при резистентных штаммах — препараты резерва по чувствительности.

Детям вводят ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. Если это не помогло, назначают цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР — со знаком #, то есть вне инструкции).

Местная и симптоматическая терапия

Нос промывают изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы используют только в остром периоде и не дольше 5–7 дней.

Сосудосуживающие капли КР называет абсолютно необходимыми, но ограничивает их 5–7 днями из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяют.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет).

Интраназальные глюкокортикостероиды пациентам старше 12 лет назначают одни при затяжном поствирусном синусите или вместе с системными антибиотиками. Детям до 12 лет одни глюкокортикостероиды назначают только при сопутствующем аллергическом рините.

Для лечения синусита без признаков бактериальной инфекции одним препаратом в России зарегистрирован только спрей мометазона.

Местные антибактериальные препараты назначают вместе с системными или одни при лёгком синусите с признаками бактериального воспаления (гнойными выделениями). Эффект оценивают через 3–4 дня.

При синусите зарегистрированы фрамицетин (детям с первых лет жизни) и комбинация дексаметазона, неомицина, полимиксина B и фенилэфрина (с 2,5 лет). Растворы антибиотиков для инъекций вводить в нос и пазухи нельзя.

При температуре, головной и лицевой боли назначают НПВП. Детям до 6 лет — только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки), взрослым можно кетопрофен.

Можно назначить мукоактивные препараты, например ацетилцистеин или карбоцистеин. Перед назначением проверьте инструкцию: не все они разрешены при ЛОР-болезнях и вместе с антибиотиками.

Применяют растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.

Комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов можно давать для облегчения симптомов с 12 лет.

Системные антигистаминные препараты назначают при сопутствующем аллергическом рините и в начале вирусной инфекции.

При вирусном синусите в комплексное лечение можно включить противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

При лёгком синусите амбулаторно можно рассмотреть комплексные гомеопатические препараты по зарегистрированным показаниям.

Бактериофаги назначают взрослым с острым бактериальным синуситом; местно они оправданы при устойчивости к антибиотикам или их непереносимости.

Хирургия

Пункцию верхнечелюстной пазухи делают, если содержимое в пазухе подтверждено рентгенологически и течение тяжёлое или среднетяжёлое без эффекта от лечения с системными антибиотиками за 5–7 дней.

Детям пункцию и трепанопункцию делают только в стационаре; часто вместо них можно использовать синус-катетер.

Дренирование пазух, в том числе синус-катетером, проводят при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите оно не нужно.

При орбитальных или внутричерепных осложнениях оперируют в стационаре: вскрывают пазуху и дренируют абсцесс.

Другое лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не нужны.

Профилактика

Детям из групп риска по респираторным болезням назначают местные и системные лизаты бактерий.

При рецидивирующем синусите и изменениях перегородки или латеральной стенки носа, которые к нему предрасполагают, проводят плановую операцию.

Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит затягивает синусит: нужны системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Одонтогенный синусит лечат хирургически, удаляя пломбировочный материал и секвестры. Из антибиотиков предпочтительны респираторные фторхинолоны, потому что преобладает анаэробная флора.

Госпитализация и осложнения

разделы 1.5, 3 и 6 текста КР
Экстренно в ЛОР-отделение госпитализируют при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, если за 3–5 дней системных антибиотиков нет улучшения и при прогрессирующем ухудшении в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения говорят о тяжёлом течении, острый средний отит — о среднетяжёлом.

Выписывают, когда состояние стабильно удовлетворительное не меньше 3 дней.

Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`313_3` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

Что исправлено после сверки с PDF

- Убрано предупреждение «пересмотр не позднее 2026»: в PDF и в карточке рубрикатора этой даты нет, она пришла из пересказа MedElement.
- Амоксициллин у взрослых: «500–1000 мг» заменено на две дозы с условием — 500 мг без факторов риска устойчивости пневмококка, 1000 мг при их наличии.
- Добавлены условия для амоксициллина/клавуланата и цефоперазона/сульбактама, тиамфеникол для детей в стационаре, предел цефуроксима «500 мг в сутки».
- Уточнены показания к пункции, ограничение ИГКС до 12 лет (только монотерапия), признаки степеней тяжести, критерии у детей («бесцветные или светлые выделения»).
- Убрана фраза «КТ рутинно не нужна»: в КР её нет.
- Добавлены разделы 5 «Профилактика» и 7 «Дополнительная информация».

Неточности в самом тексте КР

- Детская доза амоксициллина: текст раздела 3.1 — 50–60 мг/кг/сут, таблица 5 — 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- В таблице 5 у цефтриаксона указан код АТХ J01FA09 — это код кларитромицина; в тексте у цефтриаксона верный код J01DD04.
- Знак # у ряда препаратов в этой КР не расшифрован. ⚠ В российских КР им обычно отмечают применение вне инструкции — проверьте по инструкции препарата.

Шкалы доказательности

Шкала	Что означает
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности важны, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии важны, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательств надлежащего качества нет
УДД 1–5	Для лечения: 1 — систематический обзор РКИ с метаанализом … 5 — только обоснование механизма действия или мнение экспертов. Для диагностики — отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка — по нажатию на бейдж

Острый тонзиллит и фарингит

Клинические рекомендации от 31.10.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

нажмите код — скопируется

- **J02** Острый фарингит
- **J02.0** Стрептококковый фарингит
- **J02.8** Острый фарингит, вызванный другими уточнёнными возбудителями
- **J02.9** Острый фарингит неуточнённый
- **J03** Острый тонзиллит
- **J03.0** Стрептококковый тонзиллит
- **J03.8** Острый тонзиллит, вызванный другими уточнёнными возбудителями
- **J03.9** Острый тонзиллит неуточнённый

Главное

- Чаще всего тонзиллофарингит вызывают вирусы, и антибиотик при нём не нужен. Из бактерий лечения требует только БГСА — бета-гемолитический стрептококк группы А; стафилококк, пневмококк и другие микробы в мазке из зева означают колонизацию.
- По клинике вирусный тонзиллофарингит от бактериального не отличить. Пациентам старше 3 лет делают экспресс-тест на БГСА; если у ребёнка он отрицательный, результат подтверждают посевом.
- Антибиотик назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе. При вирусной инфекции он не помогает и не предотвращает присоединение бактерий.
- Препарат выбора — амоксициллин, курс 10 дней.
- Если через 48–72 часа приёма антибиотика улучшения нет, пересматривают диагноз: это может быть ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.
- Рутинно не нужны СРБ, прокальцитонин, общий анализ крови в поликлинике, АСЛ-О и контрольный мазок после лечения.

Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

Определение

Острый тонзиллофарингит — острое инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки: нёбных миндалин и фолликулов задней стенки глотки. Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, потому что чаще воспалены оба отдела.

По локализации различают тонзиллит, фарингит и тонзиллофарингит — по тому, какой отдел ротоглотки воспалён больше. По причине — стрептококковый и нестрептококковый (вирусный). Тактику определяет именно причина.

Клиническая картина

Болезнь начинается остро, обычно с температурой выше 38 °C (реже она нормальная или субфебрильная) и боли в горле, которая усиливается при глотании и может отдавать в ухо. Регионарные лимфоузлы бывают увеличены и болезненны, маленькие дети отказываются от еды. Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

На стрептококк указывают увеличенные подчелюстные или переднешейные лимфоузлы, высокая температура, сильная боль в горле, «пылающий зев», налёт на миндалинах и отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

На вирусную природу указывают насморк, конъюнктивит и кашель. При инфекции вирусом Эпштейна — Барр бывают генерализованное увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки. Петехии на мягком нёбе встречаются и при стрептококке, и при вирусе Эпштейна — Барр.

При тонзиллофарингите миндалины увеличены симметрично, и этим он отличается от паратонзиллярного абсцесса.

Что важно для выбора тактики

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. К макролидам устойчив примерно каждый пятый штамм, к клиндамицину — 3–4%.

Если при клинике тонзиллофарингита из зева высевают *S. aureus*, *S. pneumoniae* или другие бактерии, это колонизация, и антибиотики не нужны.

Дифференциальная диагностика

Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и молодые взрослые до 30 лет. Характерны слабость, увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в крови. Диагноз подтверждают ПЦР на ДНК вируса Эпштейна — Барр и IgM к капсидному антигену.

Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети до 5 лет, обычно летом: во рту появляются пузырьки без налётов на миндалинах, а на кистях и стопах — сыпь.

При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине образуется некротическая язва с гнилостным запахом.

При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом и оставляет кровоточащую поверхность.

Синдром Маршалла (PFAPA) — периодическая лихорадка до 39–40 °C с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей — 5 лет, приступ быстро снимают системные кортикостероиды.

Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят по жалобам на сильную боль в горле при глотании, по осмотру (гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличенные регионарные лимфоузлы) и по результату экспресс-теста на БГСА или посева.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог, педиатр, врач общей практики или терапевт.

У каждого пациента нужно отличить стрептококковый тонзиллофарингит от вирусного.

Экспресс-тест на БГСА делают пациентам старше 3 лет. Если он положительный, посев не нужен. Если отрицательный, взрослому посев тоже не нужен, а у ребёнка и подростка результат подтверждают посевом.

Детям до 3 лет тест обычно не делают; исключение — когда стрептококковый тонзиллит есть у кого-то рядом, например у старшего брата или сестры.

Мазок из зева на стрептококк группы А сеют пациентам старше 3 лет, если экспресс-тест не делали или он отрицательный. Результат готов в течение 72 часов.

Мазок берут до начала антибиотиков, до утренней гигиены рта, натощак или через 2 часа после еды, под контролем орофарингоскопии, не касаясь зубов и языка, из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

Что не нужно рутинно

В поликлинике СРБ и прокальцитонин не помогают отличить вирусное воспаление от бактериального. СРБ определяют при госпитализации, прокальцитонин — у тяжёлых пациентов в стационаре.

Общий анализ крови в поликлинике делают только при необходимости, например чтобы исключить мононуклеоз.

АСЛ-О годится только для ретроспективной диагностики, потому что повышается лишь на 7–9-й день. Его определяют при подозрении на ревматическую лихорадку, гломерулонефрит или PANDAS.

Контрольный мазок на БГСА после лечения не нужен, если пациент не относится к группе высокого риска ревматической лихорадки и симптомы не повторяются.

У детей старше 3 лет обращают внимание на насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит: при стрептококковой инфекции они бывают не больше чем у 10% и только при сопутствующей вирусной инфекции.

Шкала Центора — МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Нет катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Нет показаний к посеву и/или антибиотикам
2–3	21–38% / 23–37%	Антибиотик — по экспресс-тесту и/или посеву
4 и более	57% / 55%	Антибиотик по клинической картине

Шкала FeverPAIN

Один балл дают за каждый признак: температура за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня из-за сильных симптомов, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

При 0–2 баллах вероятность стрептококка групп A, C или G — 16%, при 3 баллах — 43%, при 4–5 баллах — 63%.

Шкалы помогают найти пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, но диагноз с абсолютной точностью не ставят.

Лечение

раздел 3 текста КР

Антибиотики

При вирусной инфекции системные антибиотики не назначают: они не действуют и не предотвращают присоединение бактерий.

Назначать антибиотики при вирусном тонзиллофарингите «для профилактики» не рекомендуется.

Антибиотики назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе.

При стрептококковом тонзиллите препарат выбора — амоксициллин.

При мононуклеозе может появиться сыпь на амоксициллин, но она бывает и от других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе любых системных антибиотиков лучше избегать.

Пенициллины, цефалоспорины, линкозамиды и макролиды, кроме азитромицина, назначают на 10 дней.

При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите назначают амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям старше 3 лет) на 10 дней. Пациента консультирует оториноларинголог, чтобы исключить хронический тонзиллит, а у детей — синдром PFAPA.

Если через 48–72 часа приёма антибиотика температура и боль не уменьшились, пересматривают диагноз: вероятнее всего, это ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.

При нетяжёлой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины II–III поколения: цефуроксим, цефиксим, цефдиторен или цефподоксим. Перекрёстная аллергия с пенициллинами бывает меньше чем в 2% случаев для II поколения и меньше чем в 1% для III.

Уровни доказательности у этих препаратов в КР разные: у цефуроксима — УУР С, УДД 5; у цефиксима — С и 5 для детей, В и 1 для взрослых; у цефдиторена — С и 2; у цефподоксима — В и 2. Курс — 10 дней.

При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница) назначают макролиды или линкозамиды, помня об устойчивости стрептококка к макролидам.

Бензатина бензилпенициллин вводят однократно внутримышечно вместо курса таблеток, только если есть сомнения, что пациент будет их принимать. Детям с массой до 27 кг — 600 тысяч ЕД, больше 27 кг — 1,2 миллиона ЕД.

Дозы внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия — 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма

Препарат	Взрослые	Дети
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] Если пациент может не соблюдать назначения, при ревматической лихорадке у него или у родственников, при неблагоприятных бытовых условиях и вспышках в коллективе. [3] Клавулановой кислоты — не больше 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте — 250 мг 2 раза в сутки, в таблице — 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте — 40 мг/кг в сутки, в таблице — 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте — 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не больше 1000 мг в сутки, в таблице — в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице — 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор за врачом; проверьте дозы по инструкции в ГРЛС.

Парентерально

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, его вводят парентерально до стабилизации, а затем переходят на приём внутрь.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (тяжёлые — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч

Препарат	Дети	Взрослые
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

Симптоматическое лечение

При температуре и боли назначают ибупрофен, парацетамол или, старше 15 лет, ацетилсалициловую кислоту; детям — только парацетамол и ибупрофен. Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающее дают при температуре выше 39,0 °C в прямой кишке или выше 38,5 °C в подмышке.

Ибупрофен взрослым — 200–400 мг, детям — 7,5 мг/кг, не больше 30 мг/кг в сутки. Парацетамол взрослым — 500–1000 мг, детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не больше 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначают.

Исключение — сильный дискомфорт и угроза асфиксии, например при мононуклеозе. Тогда однократно внутрь дают #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При сильной боли назначают местные анестетики и НПВП в спреях, растворах и таблетках для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение антибиотики не заменяет.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином — старше 4 лет, флурбипрофен — старше 12 лет, кетопрофен — с 12 лет. Средства для горла вообще применяют с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. Миндалины не «смазывают» и налёт механически не снимают.

Дополнительно, в том числе курсами между рецидивами, можно применять растительные препараты: корень алтея, ромашку, тысячелистник, кору дуба, хвощ, листья грецкого ореха, одуванчик.

Пища должна быть щадящей и мягкой: не острой, не кислой, не солёной, не горячей и не холодной.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

Профилактика, госпитализация, осложнения

разделы 5–7 текста КР
После тесного бытового контакта со стрептококковой инфекцией антибиотики для профилактики назначают беременным со сроком 37 недель и больше, новорождённым и родильницам в первые 28 дней, а также людям 75 лет и старше.

Больных стрептококковым тонзиллофарингитом изолируют от организованных коллективов и ограничивают их контакты.

При рецидивирующем тонзиллофарингите для профилактики рецидивов назначают лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациента наблюдают месяц: общий анализ крови и мочи делают через 7–10 дней и через 3 недели, а при жалобах со стороны сердца — ЭКГ.

Лечат обычно амбулаторно. На антибиотиках улучшение наступает через 12–24 часа. В детский коллектив ребёнок возвращается после полного выздоровления.

В инфекционное отделение госпитализируют при тяжёлом состоянии и если из-за отказа от еды и питья нужна инфузионная терапия. При подозрении на гнойное осложнение, атипичной картине или необходимости операции пациента консультирует оториноларинголог и его госпитализируют в хирургическое отделение.

Стрептококковая инфекция даёт гнойные осложнения — паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы, гнойный лимфаденит — и негнойные: острую ревматическую лихорадку, ревматическую болезнь сердца, постстрептококковый гломерулонефрит, стрептококковый токсический шок, PANDAS.

Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина/клавуланата и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются — подробно в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» написано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед» — по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.
- Таблицы доз в PDF извлекаются вперемешку: все строки сверены по изображениям страниц 19–21.

Отит средний острый

Клинические рекомендации от 28.10.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

нажмите код — скопируется

- **H65.0** Острый средний серозный отит
- **H65.1** Другие острые негнойные средние отиты
- **H66.0** Острый гнойный средний отит

Главное

- Острый средний отит — воспаление всех трёх отделов среднего уха: барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы. Проявляется болью в ухе, температурой, снижением слуха, иногда гноетечением.
- Диагноз ставят, когда одновременно есть внезапное начало, воспаление барабанной перепонки и признаки выпота: выбухание или сниженная подвижность перепонки при пневмоотоскопии или тимпанометрии. Внезапная оторея при исключённом наружном отите тоже подтверждает диагноз.
- Детям до 2 лет с признаками острого среднего отита антибиотик назначают всегда. В любом возрасте он нужен при гнойной форме, при симптомах дольше 72 часов, рецидивирующем отите, отягощающей сопутствующей патологии и если повторно осмотреть пациента нельзя.
- Препарат первой линии — амоксициллин. Если за 3 дня эффекта нет, его меняют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Курс — 7–10 дней.
- Для обезболивания назначают НПВП или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном можно только при целой барабанной перепонке.
- Через 3–4 недели пациента осматривают повторно с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы не пропустить экссудативный средний отит.

Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

Определения

Острый средний отит — воспаление всех трёх отделов среднего уха (барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы) с одним или несколькими симптомами: болью в ухе, повышением температуры, снижением слуха, иногда гноетечением. Поражается только слизистая оболочка.

Рецидивирующим отит называют, если за 6 месяцев было 3 эпизода и больше или за 12 месяцев — 4 и больше.

Затянувшимся отит называют, если симптомы воспаления среднего уха сохраняются 3–12 месяцев после одного или двух курсов антибиотиков.

У детей бывают возбуждение, раздражительность, рвота и понос. Обычно болезнь длится не дольше трёх недель.

Стадии

1) острый евстахеит; 2) катаральное воспаление; 3) доперфоративная стадия гнойного воспаления; 4) постперфоративная стадия гнойного воспаления; 5) репаративная стадия.

В катаральной стадии барабанная перепонка гиперемирована и утолщена, опознавательные знаки едва видны или не видны.

В гнойной стадии боль резко усиливается, температура поднимается до фебрильной, перепонка ярко-красная и выбухает, опознавательных знаков нет; возможна перфорация.

В постперфоративной стадии через перфорацию в слуховой проход поступает гной.

В репаративной стадии жалоб почти нет, цвет и толщина перепонки восстанавливаются, перфорация чаще закрывается рубцом, но слизистая среднего уха ещё не восстановилась.

Тяжесть

Лёгкое течение	**Тяжёлое течение**
Нет осложнений	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Нет выбухания барабанной перепонки	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Недолгая боль в ухе, хорошо снимается лекарствами	Выраженная боль (у маленьких детей — изменения поведения), плохо или не снимается лекарствами
Общее состояние не изменено: сон, еда, активность в норме	Общее состояние изменено
Нормальная температура или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура выше 38,0 °C

Клиническая картина

У детей старше 2 лет главный признак — внезапная боль в ухе на фоне воспаления барабанной перепонки (гиперемия, выбухание, сниженная подвижность при пневмоотоскопии), а после перфорации — оторея. У маленьких детей важнее выбухание перепонки и поведение: беспокойство, отказ от еды, ребёнок дёргает и трёт ухо.

Взрослые чаще жалуются на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Тугоухость кондуктивная; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

Возбудитель и выбор антибиотика

Возбудителя иногда можно предположить по клинике: отит с конъюнктивитом чаще вызывает H. influenzae; стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей — S. pyogenes; нарастающая боль, температура и спонтанная перфорация — S. pneumoniae.

Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят, когда одновременно есть три признака: внезапное начало, воспаление барабанной перепонки (гиперемия, инфильтрация) и выпот в барабанной полости (выбухание, сниженная подвижность при пневмоотоскопии или тимпанометрии). Внезапная оторея при исключённом наружном отите тоже подтверждает диагноз.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог.

Если реактивных изменений барабанной перепонки нет, её подвижность оценивают при пневматической отоскопии.

Тональную аудиометрию проводят при затяжном течении (дольше 10 дней), рецидивирующем отите или чтобы исключить нейросенсорную тугоухость.

Развёрнутый общий анализ крови делают всем пациентам.

Прокальцитонин определяют при подозрении на тяжёлое течение или в сложных случаях, чтобы подтвердить бактериальную природу отита.

Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10^9/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороги для гнойного отита: лейкоциты >15×10^9/л — ППР 85%, ПОР 64%; СРБ >30 мг/л — ППР 79%, ПОР 52%; ПКТ >2 нг/мл — ППР 94%, ПОР 74%. Таблица в PDF — изображение; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

Гнойное отделяемое отправляют на посев с определением чувствительности, если проводят парацентез или есть отделяемое из барабанной полости, а также в стационаре при тяжёлом и рецидивирующем отите.

КТ височных костей нужна при затяжном течении (дольше 10 дней), выраженном ухудшении и при подозрении на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если КТ сделать нельзя, при тех же показаниях делают рентгенографию височных костей по Шюллеру и Майеру.

Лечение

раздел 3 текста КР

Боль и температура

При боли и лихорадке назначают НПВП или парацетамол. Их дают разово: при боли в ухе или температуре выше 38,5 °C, а если в анамнезе были фебрильные судороги — уже при 38,0 °C.

Детям до 6 лет можно только парацетамол — до 60 мг/кг в сутки (10–15 мг/кг на приём) — или ибупрофен — до 30 мг/кг в сутки (8–10 мг/кг на приём).

Для местного обезболивания назначают ушные капли с лидокаином и феназоном, но только если барабанная перепонка цела.

Когда нужен антибиотик

Системные антибиотики назначают при наличии показаний.

Показание	Когда
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при клинических признаках ОСО
Гнойная форма — в любом возрасте	Перфорация с гнойным отделяемым; или без перфорации — боль, не снимаемая анальгетиками, с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков, выбуханием перепонки

Показание	Когда
Симптомы дольше 72 часов — в любом возрасте	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО 72 часа и более от начала
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицит, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Нельзя повторно осмотреть	Нет возможности контрольного осмотра с отоскопией у ЛОР-врача или врача общей практики

Выбор антибиотика

Препарат первой линии — амоксициллин, если пациент не принимал его последние 30 дней, у него нет гнойного конъюнктивита и непереносимости аминопенициллинов.

Вторая линия — защищённые пенициллины или цефалоспорины III поколения. Если за 3 дня амоксициллин не помог, его меняют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

При затянувшемся и рецидивирующем отите сразу начинают с амоксициллина с клавулановой кислотой или цефиксима внутрь.

Макролиды у детей — третья линия, и только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, потому что устойчивость пневмококка к ним выше 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов назначают цефалоспорины III поколения: амбулаторно цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Курс длится 7–10 дней. Дольше лечат детей до 2 лет, пациентов с отореей и сопутствующими болезнями; при затянувшемся и рецидивирующем отите курс обычно не меньше 14 дней. Антибиотик не отменяют, пока не прекратилась оторея.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не применяют: они плохо действуют на пневмококк и гемофильную палочку и дают много побочных эффектов.

В постперфоративной стадии системные антибиотики продолжают.

Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от еды)	0,5 г × 3 р/сут без факторов риска[1]; 1,0 г × 3 р/сут при факторах риска[2]	50–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма[1]
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале еды)	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут	40–45 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г/сут в 3 введения	90 мг/кг/сут в 3 введения (4–40 кг); 60 мг/кг/сут (менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г/сут на 4 введения	150–300 мг/кг/сут на 3–4 введения

Препарат	Взрослые	Дети
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г/сут в 1 введение	50–80 мг/кг/сут в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		
Цефуроксим (сразу после еды)	500 мг/сут в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг/сут в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг/сут на 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1 приём	8 мг/кг/сут в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма

[1] [2] Без / при факторах риска устойчивости пневмококка: антибиотики за предшествующие 3 месяца; дети-дошкольники в семье, посещающие детские учреждения; проживание в «закрытых» учреждениях. [3] Факторы риска β-лактамаз: сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит), иммуносупрессия, неудача терапии амоксициллином. [4] При высоком риске осложнений.

> Внутри КР есть расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине обычная доза для детей — 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивого пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

Детям до 3 лет амоксициллин дают только в виде суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены с 12 лет; детям младше 12 лет с массой меньше 40 кг назначают гранулы, порошок для суспензии или диспергируемые таблетки.

Местная и вспомогательная терапия

При перфорации назначают ушные капли с фторхинолонами или с дексаметазоном в комбинации с противомикробными средствами, чтобы оторея прекратилась быстрее. Капли с аминогликозидами и спиртом нельзя: они ототоксичны.

Норфлоксацин разрешён детям старше 1 года, ципрофлоксацин — с 15 лет. Офлоксацин и дексаметазон с противомикробными средствами можно детям старше 1 года при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос назначают во всех стадиях, чтобы восстановить проходимость слуховой трубы, но не дольше 5–7 дней. Нафазолин не применяют.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет). До года — только капли, после года по возможности дозированный спрей.

Детям промывают нос изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. Дошкольникам большие объёмы не используют, потому что это повышает риск отита.

Муколитики можно детям старше 2 лет. Показания проверяют по инструкции: не каждый муколитик для бронхов подходит при отите.

Хирургия

Парацентез делают при выраженных симптомах и выбухании перепонки без перфорации, при боли, которую не снимают НПВП, и если через 48–72 часа приёма антибиотиков нет улучшения. В сомнительных случаях решают в пользу парацентеза.

При внутривисочных или внутричерепных осложнениях проводят экстренную антромастоидотомию.

После острого периода и госпитализация

разделы 4–6 текста КР
Через 3–4 недели оториноларинголог повторно осматривает пациента с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы исключить экссудативный средний отит.

Если после отита пациент жалуется на снижение слуха, его направляют к сурдологу-оториноларингологу.

В репаративной стадии продувают слуховые трубы и делают пневмомассаж барабанных перепонок. То, что аэрация восстановилась, подтверждают объективно, в том числе тимпанометрией.

В репаративной стадии пациента консультирует физиотерапевт.

Всех детей прививают от пневмококковой инфекции по национальному календарю.

При рецидивирующем отите планово шунтируют барабанную полость (тимпаностомия).

Экстренно госпитализируют при тяжёлом течении, при лёгком течении без улучшения на адекватном лечении за 3–5 дней и при прогрессирующем ухудшении в любой момент.

Выписывают, когда состояние стабильно удовлетворительное не меньше 3 дней.

Отит тяжелее протекает и чаще осложняется при иммунодефиците и сахарном диабете. Чаще болеют пациенты с ГЭРБ, аллергическим ринитом и курильщики, в том числе пассивные.

Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- Детская доза амоксициллина: в комментарии к рекомендации — 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивого пневмококка), в таблице 4 — 50–60 мг/кг/сут.
- Цефуроксим взрослым в таблице 4 — «500 мг/сут в 2 приёма»; проверьте по инструкции в ГРЛС.
- У ушных капель с офлоксацином в одном месте указан код АТХ S01AX13 (ципрофлоксацин), выше по тексту у офлоксацина — S01AX11.
- Таблица 2 (маркеры бактериального воспаления) в PDF вставлена изображением — её значения перенесены вручную.
- Капли с норфлоксацином: здесь — детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) — с 15 лет. Проверьте по инструкции в ГРЛС.

Паратонзиллярный абсцесс

Клинические рекомендации от 20.11.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

- **J36** Перитонзиллярный абсцесс
- **J39.0** Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс
- **J39.1** Другой абсцесс глотки

Главное

- Паратонзиллярный абсцесс лечит оториноларинголог в стационаре, и основа лечения — хирургическое вскрытие абсцесса.
- Чаще всего, более чем в 70% случаев, абсцесс располагается спереди и сверху — между капсулой миндалины и верхней частью передней дужки.
- Антибиотики широкого спектра, действующие и на анаэробы, назначают сразу, не дожидаясь посева; курс обычно 10–14 дней.
- При частых ангинах, повторном или затяжном абсцессе, плохом дренировании и кровотечении после вскрытия удаляют миндалины одновременно со вскрытием абсцесса.
- После простого вскрытия двустороннюю тонзиллэктомию делают планово через 3 месяца.

Клиника и классификация

Определение

Паратонзиллярный абсцесс — гнойное расплавление клетчатки вокруг миндалины, между её псевдокапсулой и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

Причины

Чаще всего абсцесс развивается как осложнение ангины, реже — хронического тонзиллита. Возможен одонтогенный путь — от кариеса задних нижних зубов (вторых моляров, зубов мудрости) и периостита альвеолярного отростка, а также инфицирование инородным телом, например рыбной костью.

Возбудители — чаще всего бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробы.

При обращении отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная — у 15–20%, абсцедирующая — у 80–85% пациентов. От начала болезни до абсцесса обычно проходит 4–6 дней, но иногда всего несколько часов.

Локализация

Передневерхний (супратонзиллярный) абсцесс — больше 70% случаев, между капсулой миндалины и верхней частью передней дужки. Задний — около 15%, между миндалиной и задней дужкой. Нижний — чуть больше 5%, между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки. Боковой — меньше 5%, между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

Клиническая картина

Абсцесс обычно возникает на фоне ангины или через несколько дней после неё. Сначала появляется боль при глотании, которая становится постоянной, резко усиливается при попытке проглотить слюну и отдаёт в ухо и зубы. Беспокоят головная боль и разбитость, температура поднимается до фебрильной, пациенты отказываются от еды и питья. Почти всегда постепенно нарастает тризм, речь становится невнятной и гнусавой. Из-за боли при поворотах пациент держит голову набок и поворачивается всем корпусом.

При передневерхнем абсцессе верхний полюс миндалины вместе с дужками и мягким нёбом резко выбухает к средней линии, язычок смещён в противоположную сторону, миндалина оттеснена книзу и кзади.

При заднем абсцессе припухлость видна в области задней дужки, процесс может переходить на боковую стенку глотки; миндалина и передняя дужка мало изменены, язычок и мягкое нёбо отёчны.

При нижнем абсцессе в глотке видны лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки, хотя жалобы выражены. Может вовлекаться корень языка, иногда отекает язычная поверхность надгортанника, и отёк, распространяясь на гортань, может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс встречается реже всего, но протекает тяжелее всех: гною трудно прорваться в глотку. Выражены отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения, кривошея и тризм, а в глотке видно лишь умеренное выбухание всей миндалины.

Жалобы и анамнез

Важно узнать о недавних ангинах, хроническом тонзиллите, прошлых паратонзиллитах и абсцессах и их лечении, о кариесе и возможном инородном теле, например рыбной кости.

Характерны сильная, обычно односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании и отдающая в ухо и зубы, ощущение инородного тела, гнусавость, неприятный запах изо рта, боль в шее при поворотах головы, тризм и слюнотечение. Из общих жалоб — слабость, разбитость, фебрильная температура и головная боль; они неспецифичны и требуют дифференциальной диагностики.

Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу, осмотру с тщательной оценкой подчелюстной области и лимфоузлов, фарингоскопии и анализам.

Каждого пациента с подозрением на абсцесс осматривает оториноларинголог.

Местные признаки, наиболее выраженные при переднем абсцессе: яркая гиперемия, отёк и инфильтрация дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка, асимметрия мягкого нёба, смещение миндалины, ограничение открывания рта, регионарный лимфаденит.

Фарингоскопию проводят всем детям и взрослым; её данные решают диагноз.

Если есть подозрение, что воспаление распространилось на гортаноглотку, проводят непрямую ларингоскопию или фиброларингоскопию.

КТ и УЗИ шеи делают в тяжёлых случаях, когда нужно уточнить диагноз и локализацию абсцесса или отличить его от воспаления глубоких отделов шеи.

Анализы

Всем делают развёрнутый анализ крови, СРБ и анализ мочи. Высокий лейкоцитоз со сдвигом влево и высокий СРБ говорят о высоком риске осложнений и требуют коррекции лечения, в том числе антибиотиков.

Гной после вскрытия отправляют на посев на аэробы и анаэробы с определением чувствительности, а мазок с миндалин — на дифтерийную палочку, чтобы исключить дифтерию.

Лучше брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости: ферменты гноя разрушают микробы. Материал доставляют в лабораторию в транспортной среде, оптимально за 40 минут.

Дифференциальная диагностика

Абсцесс отличают от дифтерии, скарлатины, абсцесса язычной миндалины, абсцессов подъязычной области, флегмоны дна полости рта, опухолей ротоглотки и перикоронита.

При дифтерии слизистая бледно-цианотичная, налёты сероватые и выходят за пределы миндалин, но тризма нет.

При скарлатине есть сыпь на коже, чёткая граница поражённой слизистой и «малиновый» язык. При абсцессе язычной миндалины нет тризма и типичных изменений в ротоглотке. При флегмоне дна полости рта боль и отёк в подчелюстной области, язык малоподвижен, а дужки и миндалины не изменены.

Опухоли миндалины развиваются медленно, без температуры, сильной боли и тризма, а лимфоузлы плотные, малоболезненные и малоподвижные.

Изредка припухлость в глотке вызвана близко расположенной сонной артерией или её аневризмой; диагноз подсказывает видимая пульсация.

Лечение

Пациента лечит оториноларинголог в специализированном учреждении; основа лечения — хирургическая санация полости абсцесса.

Хирургическое лечение

Впервые возникший абсцесс вскрывают и дренируют.

Правила при любой технике: убедиться, что в месте вскрытия нет пульсации; глубже 0,5 см продвигаться только тупым путём; вскрывать достаточно широко, до 4 см.

Разрез выбирают по локализации, под местной аппликационной анестезией. Передневерхний абсцесс вскрывают через переднюю дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания, задний — через заднюю дужку, отступив 0,5 см от края, нижний — в нижней части передней дужки. Ткани рассекают вдоль сосудов на глубину 0,5–1 см, дальше раздвигают корнцангом.

Затем регулярно разводят края разреза, пока полость не начнёт заживать.

При частых ангинах в анамнезе, повторном паратонзиллите или абсцессе, затяжном течении, плохом дренировании и кровотечении после вскрытия удаляют нёбные миндалины одновременно со вскрытием абсцесса: так убирается и сам очаг инфекции.

Такую операцию делают в любом возрасте, от 3–4 до 70 лет и старше. Противопоказания — терминальное или крайне тяжёлое состояние из-за болезней внутренних органов, тромбоз сосудов мозга, разлитой менингит.

После операции осматривают нишу миндалины: выпячивание в ней — признак парафарингеального абсцесса.

Антибиотики

Системные антибиотики назначают сразу, не дожидаясь посева. Так как в абсцессе обычно есть анаэробы, нужны препараты широкого спектра, которые действуют и на них.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	С 12 лет или с массой от 40 кг — 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. Можно #амоксициллин с сульбактамом по 1 г 2–3 раза в сутки с 12 лет, до 10 дней. Детям до 12 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Цефтриаксон	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки; длительность в таблице КР указана так: «в течение 4–14 дней до 10 дней». Новорождённым до 2 недель — 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не больше 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки.
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки, до 10 дней. Новорождённым и детям до 12 лет — 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; недоношенным — не больше 50 мг/кг в сутки.
Клиндамицин	300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении — до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма. Детям при непереносимости цефалоспоринов III поколения — #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

Курс обычно 10–14 дней. Препараты выбора — пенициллины, в том числе с ингибиторами бета-лактамаз. Если глотать таблетки трудно, используют диспергируемые формы, суспензии или инъекции. При выраженном отёке тканей глотки и шеи, сильном тризме и высоком риске генерализации назначают парентеральные цефалоспорины III поколения, а при их непереносимости — клиндамицин. Детям предпочтительны ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой.

Другие лекарства

При выраженных воспалительных проявлениях назначают НПВП в обычных дозах.

Всем назначают системные антигистаминные препараты.

КР рекомендует и средства для повышения сопротивляемости — препараты кальция, витамины С и А, — избегая полипрагмазии.

При выраженной интоксикации проводят инфузионную дезинтоксикационную терапию.

Всем назначают местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства: полоскания, инсуффляции, ингаляции, таблетки для рассасывания. Системные антибиотики они не заменяют.

После операции, не раньше чем через 3 недели после стихания воспаления, пациента консультирует физиотерапевт.

После вскрытия

После вскрытия абсцесса двустороннюю тонзиллэктомию делают планово через 3 месяца.

После тонзиллэктомии месяц ограничивают физическую нагрузку.

Профилактика, госпитализация, осложнения

При диспансеризации выявляют факторы риска — хронический тонзиллит и рецидивирующие ангины; профилактика включает закаливание и своевременное лечение зубов и дёсен.

Лечат в хирургическом стационаре. Показание к госпитализации — необходимость вскрыть абсцесс или удалить миндалины со вскрытием абсцесса. После вскрытия состояние улучшается уже через 12–24 часа. После абсцесстонзиллэктомии без осложнений выписывают на 5–7-е сутки.

Без лечения или при неправильном лечении высок риск гнойных осложнений: флегмоны шеи, медиастинита, тонзиллогенного сепсиса, инфекционно-токсического шока. Риск выше при иммунодефиците — врождённом, на иммуносупрессорах и цитостатиках, при ВИЧ.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- Для цефтриаксона в таблице 1 написано «в течение 4-14 дней до 10 дней» — сроки противоречат друг другу; на сайте указано «до 10 дней».
- Знак # у амоксициллина с сульбактамом и у детской дозы клиндамицина означает применение вне инструкции.

Хронический тонзиллит

Клинические рекомендации от 20.11.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

- **J35.0** Хронический тонзиллит — при воспалении нёбных миндалин
- **J35.8** Другие хронические болезни миндалин и аденоидов — при воспалении язычной, трубных или глоточной миндалины
- **J35.9** Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточнённая
- **J31.1** Хронический назофарингит

Главное

- Диагноз ставят по фарингоскопии: решают местные признаки хронического воспаления миндалин, и важнее всего жидкий гной в лакунах. Размер миндалин для диагноза значения не имеет.
- Во время острого воспаления глотки хронический тонзиллит не диагностируют: признаки можно достоверно оценить только через 3–4 недели после него.
- По классификации Солдатова тонзиллит бывает компенсированным и декомпенсированным; форму определяют по анамнезу за последние три года.
- Консервативное лечение проводят курсами между обострениями: при компенсированной форме 2 раза в год, весной и осенью, при рецидивах ангин — до 4 раз в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Тонзиллэктомия показана при любой декомпенсации, а при рецидивирующих ангинах — если противорецидивное лечение не помогло.

Клиника и классификация

Определение

Хронический тонзиллит — инфекционно-аллергическое заболевание всего организма с местными проявлениями: стойким воспалением нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

Местные признаки

Выделяют пять групп местных признаков: гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек; рубцовые спайки между миндалинами и дужками; разрыхлённые или, наоборот, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины; казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах; увеличенные регионарные лимфоузлы.

Признак Гизе — гиперемия краёв передних дужек. Признак Зака — отёк в месте соединения передних и задних дужек. Признак Преображенского — валикообразное утолщение краёв верхних отделов передних и задних дужек.

Классификация Солдатова

При компенсированной форме местные признаки видны, а общих симптомов почти или совсем нет. При декомпенсированной к местным признакам добавляется хотя бы один вид декомпенсации: рецидивы ангин; паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс; тонзиллогенная интоксикация — долгий субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности без другой причины; тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов; заболевания органов, связанные с тонзиллитом. Форму определяют по анамнезу за последние три года.

Классификация Преображенского — Пальчуна

При простой форме есть только местные признаки, и почти всегда в анамнезе были ангины.

При токсико-аллергической форме I степени периодически бывают субфебрилитет, слабость, быстрая утомляемость, боли в суставах, увеличенные и болезненные регионарные лимфоузлы, непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца и нестойкие отклонения в анализах.

При II степени функциональные нарушения сердца подтверждаются на ЭКГ, бывают сердцебиение и нарушения ритма, боли в сердце и суставах во время ангины и вне её, функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов, а также связанные с тонзиллитом болезни: паратонзиллярный абсцесс, парафарингит, тонзиллогенный сепсис, ревматизм, артрит, приобретённые пороки сердца, гломерулонефрит.

Описано около 100 болезней, связанных с хроническим тонзиллитом; чаще всего страдают сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В трудных случаях тактику выбирают вместе с профильным специалистом.

Жалобы и анамнез

Пациенты могут жаловаться на несильную боль, першение, ощущение инородного тела в горле, периодический сухой кашель и неприятный запах изо рта. Эти жалобы неспецифичны — они бывают и при хроническом фарингите, болезнях гортани, полости рта и зубов, — а у части пациентов их нет вовсе.

При декомпенсированной форме бывают общие жалобы: долгое недомогание, снижение работоспособности, затяжной субфебрилитет. Они тоже неспецифичны, поэтому нужно обследование, чтобы исключить другие причины.

У детей и взрослых, особенно часто и долго болеющих, выясняют местные и общие жалобы и уточняют, как часто были ангины. Ангины в анамнезе многие авторы считают самым надёжным признаком хронического тонзиллита, но сведения о них должны быть подтверждены.

Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу (ангины, долгая утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, болезни, связанные с тонзиллитом), осмотру, лабораторным данным и фарингоскопии.

Осмотр

Фарингоскопию проводят детям и взрослым, чтобы исключить острый тонзиллит и найти местные признаки хронического.

Пока есть острое воспаление глотки, хронический тонзиллит не диагностируют: его признаки можно достоверно оценить только через 3–4 недели.

Всем проводят осмотр верхних дыхательных путей с хорошим освещением, шпателем и зеркалами, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Решающее значение имеют фарингоскопические признаки, и важнее всего жидкий гной в лакунах, часто с неприятным запахом. Увеличение лимфоузлов может быть вызвано и другими воспалительными процессами головы и шеи. Размер миндалин для диагноза значения не имеет.

Осматривают при ярком направленном свете двумя шпателями, при необходимости зондом. За 20–30 минут до осмотра пациенту не стоит есть, пить горячее, холодное и газированное, курить и разговаривать на холоде, чтобы не было преходящей гиперемии. Вторым шпателем надавливают на дужку, чтобы увидеть содержимое лакун и спайки.

Анализы

Общий анализ крови и мочи, СРБ и ревматоидный фактор назначают, чтобы выявить связанное с тонзиллитом заболевание.

Антистрептолизин-О (АСЛ-О) определяют, чтобы отличить активную стрептококковую инфекцию от носительства.

Высокий АСЛ-О без стрептококка в посевах говорит о возможной внутриклеточной персистенции и считается подтверждением декомпенсации. Но высокий АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не повод для лечения.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

Отделяемое с нёбных миндалин сеют на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или делают экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитология содержимого лакун для самого диагноза значения почти не имеют. Они нужны, чтобы уточнить форму, роль микрофлоры, связь с болезнями других органов и эффект лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, УЗИ и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательств их эффективности нет.

Лечение

Хронический тонзиллит лечат между обострениями. Ангину лечат по рекомендациям по острому тонзиллофарингиту, а паратонзиллит и абсцесс — по рекомендациям по этим заболеваниям.

Перед любым лечением проверяют зубы, околоносовые пазухи и носоглотку и при необходимости санируют их.

Консервативное лечение

Консервативное лечение показано при компенсированной и простой форме — курсами 2 раза в год, весной и осенью. При декомпенсации в виде рецидивов ангин и при токсико-аллергической форме I степени — до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины. При других видах декомпенсации и токсико-аллергической форме II степени — если операция противопоказана.

Лечение помогает, только если лакуны дренируются, а складки и карманы очищаются от экссудата и детрита.

Системные антибиотики назначают при обострении, если выделен стрептококк или появляются признаки осложнений, — это пенициллины. Вне обострения, при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных посевах на БГСА и стойко высоком АСЛ-О, предпочтение отдают 14-членным макролидам, курсом до 2 недель.

Нужны ли антибиотики между обострениями, специалисты спорят, поэтому решение принимают индивидуально, по объективным данным и динамике симптомов и анализов.

Если подтверждена грибковая природа, назначают противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

Между обострениями курсами назначают растительные препараты с корнем алтея, цветками ромашки, травой тысячелистника, корой дуба, травой хвоща и корнем одуванчика, чтобы реже были ангины.

Местное лечение

Между обострениями промывают лакуны миндалин: курс из 10 процедур ежедневно или через день. Промывать можно не раньше чем через 2–3 недели после острого воспаления.

Промывают стерильным раствором натрия хлорида или растворами антисептиков, соблюдая дозы и возрастные ограничения и помня об аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур проводят отдельно или сразу после промывания.

Детям дошкольного и младшего школьного возраста миндалины не промывают и не смазывают из-за риска рефлекторного ларингоспазма.

Назначают антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.

Взрослым при обострении назначают НПВП для местного применения.

Топические бактериальные лизаты в таблетках для рассасывания уменьшают число и длительность обострений.

В ремиссии пациента консультирует физиотерапевт; перед физиотерапией проводят курс промываний.

Тонзиллэктомия

Двустороннюю тонзиллэктомию делают между обострениями, чтобы радикально убрать очаг инфекции.

По классификации Солдатова операция показана при любой декомпенсации, кроме рецидивов ангин, если противорецидивное лечение не проводилось. При рецидивах ангин — если консервативное лечение не помогло и ангины продолжаются или появился другой вид декомпенсации.

По классификации Преображенского — Пальчуна — при токсико-аллергической форме II степени, а также при простой форме и форме I степени, если 2–3 тщательных курса консервативного лечения в год не помогли.

Детям операция показана при частых стрептококковых ангинах (не меньше 7 за последний год, не меньше 5 в год за последние 2 года или не меньше 3 в год за последние 3 года), при двух паратонзиллярных абсцессах и больше (иногда и после одного) и по заключению профильных специалистов, если операция нужна для лечения сопутствующей болезни.

Критерии Paradise: тонзиллэктомию рассматривают при 7 эпизодах боли в горле за год, 5 в каждом из двух лет или 3 в каждом из трёх лет. Эпизодом считается боль в горле хотя бы с одним признаком: температура 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, шейные лимфоузлы больше 2 см и болезненные, БГСА в посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютные противопоказания: болезни крови (гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы), аномальные сосуды глотки (пульсация боковой стенки), тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени, выраженная почечная недостаточность, тяжёлый сахарный диабет с кетонурией, тяжёлые болезни печени, тяжёлые нервно-психические болезни, злокачественные опухоли, активный туберкулёз.

Относительные противопоказания: острые инфекции и 3–4 недели после них, острые воспаления и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов, эпидемии гриппа, менструация, неактивный туберкулёз, преходящая тромбоцитопения, нетяжёлый сахарный диабет, кариозные зубы.

Самое частое осложнение — кровотечение из ниши миндалины во время операции или в первые 5–7 дней, но оно возможно и на 8–15-е сутки. Поэтому первые 5–7 дней пациент лежит в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике на больничном.

После операции

В первые сутки пациент соблюдает постельный режим и молчит; через несколько часов можно сделать несколько глотков воды. Дальше режим щадящий, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная. Назначают местные и системные обезболивающие и предупреждают обострение сопутствующих болезней.

Для обезболивания и уменьшения воспаления назначают НПВП.

После тонзиллэктомии месяц ограничивают физическую нагрузку, соблюдают режим сна и отдыха.

Наблюдение, профилактика, госпитализация

При компенсированной форме курсы лечения проводят 2 раза в год. Если 3 года не было ангин и других признаков декомпенсации, пациента снимают с диспансерного учёта.

При декомпенсации в виде рецидивов ангин курсы проводят 3–4 раза в год. Если за год лечение не помогло, ангины осложняются или появляется другой вид декомпенсации, пациента направляют на операцию.

После тонзиллэктомии пациент находится на диспансерном наблюдении 6 месяцев.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно недостаток витаминов A, B, E), переутомление, плохая гигиена жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, болезни зубов, носа и пазух, частые ОРВИ и их неправильное лечение.

Лечит обычно оториноларинголог амбулаторно.

В хирургическое отделение госпитализируют при неэффективности лечения, подозрении на гнойное осложнение (паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит) или новообразование и когда нужна операция. Тонзиллэктомию проводят в ЛОР-отделении планово и выписывают на 5–7-е сутки, если послеоперационный период протекает без осложнений.

Тонзиллит чаще переходит в декомпенсированную форму при иммунодефиците (врождённом, на иммунодепрессантах и цитостатиках, при ВИЧ). Аутоиммунные осложнения вероятнее при стрептококковом тонзиллите и ревматической лихорадке у пациента или близких родственников.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», а в карточке рубрикатора — J31.2 «Хронический фарингит». На сайте приведён код из текста КР.
- Бензидамин в комментарии отнесён к «пенициллинам, чувствительным к бета-лактамазам» (код АТХ J01CE) — это ошибка: бензидамин — нестероидный противовоспалительный препарат для местного применения.